Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Тонзилектомия

Операция на сливиците (пълно или частично отстраняване)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Планирана техника:
☐ Студена дисекция ☐ Електрокоагулация
☐ Радиочестотна / коблация
☐ Тонзилотомия (частично отстраняване)

Допълнителни процедури по време на същата операция:
☐ Аденоидектомия ☐ Вентилационна тръбичка ☐ Няма
_____

Показание за операцията (попълва се от лекаря):
☐ Чести ангини (тонзилити) ☐ Нарушено дишане в съня / хъркане
☐ Перитонзиларен абсцес
☐ Едностранно уголемяване / хистологична диагноза _____

Друго / пояснения: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Сливиците (тонзилите) са лимфна тъкан, разположена от двете страни на гърлото над корена на езика, която е част от защитната система на организма. След отстраняването им защитната система продължава да работи чрез другите лимфни тъкани в устата и гърлото; не е доказано, че операцията отслабва имунитета.

Тонзилектомия най-често се препоръчва при: **ангини**, които се повтарят многократно през годината и водят до отсъствия от училище или работа; уголемени сливици, които причиняват **хъркане и паузи в дишането по време на сън**; **абсцес около сливицата (перитонзиларен абсцес)**; едностранно уголемяване на сливица или подозрителна промяна в тъканта. При някои пациенти причина за операцията могат да бъдат и лошият дъх от устата и тонзиларните камъчета.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Целта на операцията е да премахне или да намали тези оплаквания. Лекарят ще ви обясни отделно защо операцията се препоръчва на вас или на вашето дете.

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва под обща анестезия в операционна зала, през устата; **отвън няма разрези или белези.**

1. **Подготовка:** След въвеждането в анестезия се поставя специален инструмент, който държи устата отворена и предпазва езика.
2. **Отстраняване на сливиците:** Всяка сливица заедно с обвиващата я капсула се отделя от мускулния слой под нея и се отстранява. В зависимост от планираната техника това се извършва с ножици и инструменти за дисекция (студена дисекция), електрокоагулация или радиочестотни/коблационни апарати.
3. **Частично отстраняване (тонзилотомия):** При подходящи пациенти, особено малки деца с нарушено дишане по време на сън, може да се отстрани само уголемената част на сливицата, като се остави тънък слой. При този метод болката и рискът от кървене може да са по-малки; останалата тъкан обаче може да нарасне отново или да се възпали.
4. **Овладяване на кървенето:** Кървенето в ложите на сливиците се спира внимателно с шевове, лигатури или коагулация. Ложите обикновено се оставят отворени и заздравяват сами.
5. **Допълнителни процедури:** Ако е планирано, по време на същата анестезия се извършва отстраняване на аденоидите (аденоидектомия) или поставяне на вентилационни тръбички в тъпанчетата; за тези процедури се попълват отделни формуляри за съгласие.
6. **Събуждане и наблюдение:** След операцията пациентът се наблюдава в зала за събуждане, а след това в отделението по отношение на кървене, дишане и прием на течности.

Ако лекарят прецени, че е необходимо, отстранените сливици се изпращат за хистологично изследване.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия	Около 30–45 минути (без времето за анестезия)	Обикновено една нощ наблюдение в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Значително намаляване на честите ангини и свързаните с тях температура, болки в гърлото, прием на антибиотици и отсъствия от училище или работа
- По-малко хъркане и паузи в дишането по време на сън; по-качествен сън, подобрено внимание и поведение през деня
- Предотвратяване на повторен перитонзиларен абсцес
- При необходимост — точна диагноза чрез хистологично изследване на тъканта

При правилно подбрани пациенти честите инфекции на гърлото и нарушенията на дишането по време на сън се подобряват в голяма степен. И след операцията понякога може да има възпаление на гърлото (фарингит), но обикновено то е по-рядко и по-леко. Ако сънната апнея има и други причини — например наднормено тегло, особености в строежа на лицето или запушен нос — оплакванията може да не изчезнат напълно и да е необходимо допълнително лечение.

4 Други възможности за лечение

- **Наблюдение:** Ако честотата на инфекциите не отговаря на критериите за операция или оплакванията са леки, може да е подходящо да се изчака с редовни прегледи. При децата ангините могат да стават по-редки с възрастта.
- **Антибиотици и поддържащо лечение:** Всеки епизод на инфекция продължава да се лекува с лекарства; това не предотвратява следващите епизоди.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Частично отстраняване (тонзилотомия):** При подходящи пациенти може да се обсъди вместо пълно отстраняване (описано по-горе).
- **Други възможности при сънна апнея:** Намаляване на теглото, лечение на запушения нос, назални спрейове с кортикостероид или апарат за дишане с положително налягане (CPAP) по време на сън.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Без операция честите ангини, температурата, приемът на антибиотици и отсъствията от училище или работа може да продължат. Рядко може да се образува абсцес около сливицата или инфекцията да се разпространи в тъканите на шията. Ако сънната апнея, причинена от уголемените сливици, не бъде лекувана, особено при децата тя може да доведе до изоставане в растежа и развитието, проблеми с вниманието и поведението, нощно напикаване, а в дългосрочен план и до натоварване на сърцето и белите дробове. При подозрителни състояния, като едностранно уголемяване, отказът от операция може да забави поставянето на точна диагноза.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания (особено за кръвосъсирването) и при нужда други изследвания; ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- Задължително съобщете, ако вие или член на семейството ви имате склонност към лесно кървене, чести кръвотечения от носа, продължителна или обилна менструация, кървене, което не спира след вадене на зъб, или известно заболяване на кръвосъсирването.
- През последните **6 часа** преди операцията не трябва да се приема твърда храна и мляко; за бистрите течности спазвайте срока, определен от анестезиолога.
- Уведомете ни, ако през последните 2–3 седмици преди операцията е имало активна ангина, заболяване с температура или грип; може да се наложи операцията да бъде отложена.
- Кажете на лекаря, ако имате клатещ се зъб или зъбна протеза.
- Ако пристигате от чужбина, препоръчваме **поне 10–14 дни** след операцията да останете на място, откъдето можете бързо да се свържете с лекаря и болницата (поради риска от късно кървене).
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин E, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Денят на операцията	След събуждането има болки в гърлото, които се овладяват с обезболяващи. След като гаденето отмине, се дава вода, след това студени или хладки течности и мека храна.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	През нощта оставате в болницата под наблюдение по отношение на кървене, дишане и прием на течности.
1–4-ти ден	Болката в гърлото и излъчващата се към ушите болка са силно изразени. В ложите на сливиците се образува **бяло-жълтеникав налеп**; това е нормална част от заздравяването, а не инфекция. Възможни са лош дъх от устата и леко повишена температура. **Редовният прием на обезболяващи и пиенето на много течности** са най-важни.
5–10-и ден	Белият налеп започва да се отделя. В този период болката понякога може да се засили отново. **Тогава рискът от късно кървене е най-висок**; затова избягвайте натоварващи физически упражнения, горещи бани/сауна и твърди храни и потърсете помощ веднага при признаци на кървене.
10–14-и ден	Болката намалява осезаемо и се преминава към нормално хранене. Повечето деца се връщат на училище, а възрастните — на работа в рамките на 10–14 дни. Спортът и тежката физическа активност обикновено са разрешени след около 2–3 седмици.
3–6-а седмица	Ложите на сливиците заздравяват напълно. Извършва се контролен преглед; ако е правено хистологично изследване, резултатът се обсъжда.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Болки в гърлото (обикновено траят 7–14 дни; при възрастните са по-силни, отколкото при децата)
- Болка, излъчваща се към ушите (отразена болка; не означава, че има заболяване на ухото)
- Затруднено преглъщане и липса на апетит; известна загуба на тегло през първите дни
- Бяло-жълтеникав налеп в ложите на сливиците и лош дъх от устата
- Леко повишена температура (първите дни), гадене и повръщане от анестезията
- Временен оток на езика и мъжеца

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Кървене след операцията (късно кървене)** — Наблюдава се при около **2–5 на 100** пациенти, най-често **5–10 дни след операцията**, когато се отделя налепът. При възрастните е малко по-често, отколкото при децата. Повечето кръвоизливи са малки и спират при наблюдение, лед, местно лечение в устата или малка намеса.
- **Повторна операция поради кървене** — При около **1–3 на 100** пациенти може да се наложи **връщане в операционната под обща анестезия** за спиране на кървенето. Престоят в болницата може да се удължи.
- **Недостатъчен прием на течности и обезводняване** — Ако поради болката не се приемат достатъчно течности, особено при малките деца, може да се появят отпадналост и намалено уриниране; понякога е необходима хоспитализация за венозно вливане на течности.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Нечести състояния

- **Кръвопреливане** — Ако при кървенето загубата на кръв е голяма, може да е необходимо кръвопреливане; това се случва при **много по-малко от 1 на 100** пациенти.
- **Промяна във вкуса и изтръпване на езика** — Поради натиска на инструмента върху езика по време на операцията може да има промяна във вкуса или изтръпване на езика; обикновено отминава за няколко седмици, но рядко може да продължи месеци или да остане трайно.
- **Нараняване на зъбите, устните и езика** — Натискът на инструмента, който държи устата отворена, може да отчупи зъб (особено клатещ се или кариозен) или да причини малко изгаряне, рана или оток на устните или езика.
- **Инфекция** — В ложите на сливиците или в шията може да се развие инфекция; обикновено се лекува с антибиотици.
- **Временен носов говор** — Тъй като движенията на небцето са ограничени от болката, при говор въздухът временно може да излиза през носа; обикновено отминава за няколко седмици.
- **Повторно нарастване след тонзилотомия** — Ако е извършено частично отстраняване, останалата тъкан може да нарасне отново или да се възпали (около **1–6 на 100**); рядко след това може да е необходима пълна тонзилектомия.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Тежко кървене и неговите последици** — Рядко кървенето може да бъде обилно и бързо. В такъв случай може да са необходими **спешна операция, кръвопреливане** и много рядко допълнителни интервенции върху кръвоносните съдове на шията. Голямата загуба на кръв или попадането на кръв в дихателните пътища могат да доведат до сериозни последици като **дихателна недостатъчност, необходимост от лечение в интензивно отделение** и свързани с това трайни увреждания.
- **Животозастрашаващи усложнения и смърт** — Смъртният изход, свързан с тонзилектомия, е изключително рядък; в медицинската литература се съобщава за около **1 на 15 000–35 000 операции**. Най-честите причини са тежко кървене и проблеми с дишането. Малките деца с тежка сънна апнея имат по-висок риск от проблеми с дишането след операцията, затова те се наблюдават по-внимателно.
- **Траен носов говор / връщане на течности през носа (велофарингеална недостатъчност)** — Много рядко; среща се главно при скрита цепка на небцето. Може да е необходима логопедична терапия или рядко коригираща операция.
- **Разместване на горните шийни прешлени (синдром на Гризел), инфекция, разпространяваща се към шията или гръдния кош** — Много редки състояния, които се лекуват успешно при ранно откриване. Могат да се проявят с постепенно засилваща се болка във врата, невъзможност за завъртане на главата, висока температура и невъзможност за преглъщане. При възникването им са необходими болнично лечение, венозни антибиотици и при нужда хирургично дрениране; при забавено лечение могат да останат трайни проблеми с врата, а разпространяващата се инфекция може да стане животозастрашаваща.
- **Белези и стесняване на гърлото и небцето** — Много рядко по време на заздравяването може да се образува прекомерна белезна тъкан, която стеснява гърлото или небцето и затруднява преглъщането или говора.
- **Болка или изкълчване на челюстната става** — Много рядко, в резултат на продължителното държане на устата отворена.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Прясна, червена кръв** от устата, изплюване или повръщане на кръв — **дори и няколко капки** — потърсете помощ незабавно. При кървене наведете главата напред и изплювайте кръвта, вместо да я гълтате; можете да правите гаргара със студена вода.
- При деца: **често преглъщане**, бледост, отпадналост, трудно събуждане (може да е признак на погълната кръв)
- **Затруднено дишане**, изразени паузи в дишането по време на сън, шумно дишане
- **Температура над 38,5 °C**, болка, която не се повлиява от обезболяващите или се засилва
- Пълен отказ от течности, липса на уриниране в продължение на 8 часа, необичайна сънливост (признаци на обезводняване)
- Постепенно засилваща се болка във врата, невъзможност за завъртане на главата, оток на шията

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- При болка използвайте само **обезболяващите, препоръчани от лекаря**, в препоръчаната доза и през препоръчаните интервали, и ги приемайте **редовно**. Аспиринът и други обезболяващи, които лекарят не е препоръчал, могат да увеличат риска от кървене; не добавяйте лекарства по своя преценка.
- **Пиенето на много течности** е най-важното правило. Подходящи са студена или хладка вода, айрян, компот, сладолед, млечен пудинг, кисело мляко и пюрета. Избягвайте много горещи, кисели, люти и твърди/хрупкави храни (чипс, крекери, препечен хляб) за около **2 седмици**.
- През първите 2 седмици избягвайте натоварващи упражнения, горещи бани, сауна и продължително стоене на слънце.
- Можете да продължите да миете зъбите си; избягвайте силен допир до гърлото.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Препоръчваме да отложите обратния полет към чужбина, докато рискът от късно кървене отмине (обикновено **10–14 дни след операцията**). Ако трябва да летите по-рано, обсъдете рисковете с лекаря.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Беше ми обяснено ясно, че през първите 2 седмици след операцията, особено между 5-ия и 10-ия ден, **може да настъпи късно кървене**; че в такъв случай трябва незабавно да се свържа с лекаря или да отида в най-близкото спешно отделение; и че кървенето може да наложи повторна операция, кръвопреливане и рядко лечение в интензивно отделение.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.